“Um Dia Sem Lista É um Dia Perdido”: Indícios de Sintomas Obsessivo-Compulsivos no Comportamento de Twilight Sparkle

E. Orozcco et al.[1]

[1] *Departamento de Psicologia Aplicada à Cultura Pop* · *02/11/2026*

Resumo. Este estudo analisa, de forma qualitativa, o comportamento da personagem Twilight Sparkle (*My Little Pony: A Amizade É Mágica*) à luz dos critérios do DSM-5 para o Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC). Com base em episódios-chave e em material audiovisual de referência, discutem-se obsessões, compulsões, perfeccionismo e busca de reasseguramento. Modelos diferenciais, markovianos e bayesianos são propostos. Conclui-se que a personagem apresenta um padrão *compatível* com traços obsessivo-compulsivos, mas que a natureza ficcional do objeto impede qualquer diagnóstico formal. **Palavras-chave:** TOC; Twilight Sparkle; perfeccionismo; ansiedade; psicologia da mídia.

1. Introdução

O TOC é caracterizado por obsessões (pensamentos, imagens ou impulsos intrusivos e indesejados) e compulsões (comportamentos ou rituais mentais repetitivos realizados para reduzir a ansiedade) [1]. Estima-se que a prevalência ao longo da vida seja de cerca de 2% [2]. Personagens ficcionais frequentemente exibem traços que permitem discussões psicológicas didáticas, ainda que sem valor diagnóstico.

Twilight Sparkle, unicórnio (depois alicórnio) estudiosa e protagonista da série, destaca-se por listas minuciosas, cronogramas rígidos, medo intenso de falhar e reações desproporcionais a pequenos desvios de planos. Este trabalho pergunta: **esses comportamentos são melhor entendidos como simples traços de personalidade ou como um quadro compatível com TOC?**



Figura 1: Twilight Sparkle em suas diferentes versões (pônei, alicórnio, humana e *chibi*).

2. Método

Realizou-se uma análise qualitativa de conteúdo de três episódios: *Winter Wrap Up* (T1E11), *Lesson Zero* (T2E3) e *It's About Time* (T2E20) [10], complementada pelo vídeo de referência indicado pelo autor [11]. Cada cena foi codificada segundo categorias inspiradas nas dimensões clássicas do TOC (simetria/ordem, dúvida/verificação, responsabilidade excessiva e catástrofe iminente) [3, 4].

A frequência apresentada na Figura 2 é uma **estimativa subjetiva do autor** (escala de 0 a 5), com caráter ilustrativo, e não resulta de medição estatística validada. Trata-se de limitação importante, discutida adiante.

3. Resultados

3.1. Obsessões

Em *Lesson Zero*, Twilight é tomada pela certeza de que não entregar o relatório de amizade levará a consequências graves. O pensamento é intrusivo, persistente e aumenta de intensidade, o que lembra o fenômeno de *fusão pensamento-ação*, em que pensar em um desastre parece torná-lo mais provável [7]. Em *It's About Time*, a antecipação de uma catástrofe futura domina seu comportamento, em linha com a **responsabilidade inflada** descrita nos modelos cognitivos [5, 6].

3.2. Compulsões e rituais

Observam-se (i) elaboração obsessiva de listas e agendas, (ii) organização rígida e padronizada da biblioteca, (iii) revisão repetida de tarefas já concluídas e (iv) busca frequente de reasseguramento, geralmente de Spike. Conforme o modelo de aprendizagem do TOC, tais comportamentos reduzem a ansiedade no curto prazo, mas reforçam o ciclo a longo prazo [8].

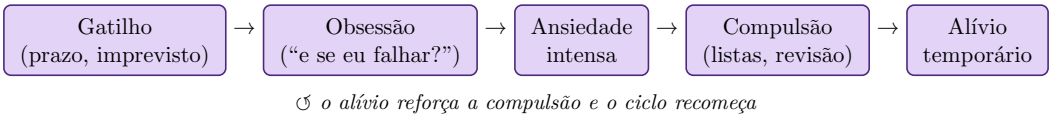


Figura 2: Ciclo obsessão–compulsão aplicado ao comportamento de Twilight.

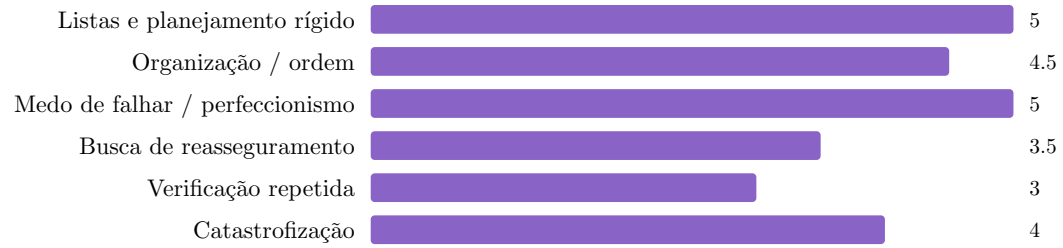


Figura 3: Intensidade estimada de comportamentos relevantes (0–5). *Dados ilustrativos, baseados em avaliação qualitativa do autor.*

Critério (DSM-5)	Evidência observada	Compatibilidade
Obsessões recorrentes	Medo persistente de falhar e de catástrofes	Alta
Compulsões / rituais	Listas, revisão e organização excessivas	Alta
Consumo de tempo ou sofrimento	Crises em *Lesson Zero*; insônia em *It's About Time*	Moderada
Prejuízo funcional	Afeta amizades e decisões, mas recupera-se rapidamente	Baixa
Exclusão de outras causas	Perfeccionismo e ansiedade explicam parte do quadro	Baixa

Tabela 1: Correspondência entre critérios diagnósticos e comportamentos observados.

4. Modelagem Matemática do Comportamento Sparkliano

Dinâmica da ansiedade. Seja $A(t)$ o nível de ansiedade e $O(t)$ a intensidade de obsessões no instante t. Propõe-se o modelo diferencial estocástico (Luna, 2015 [14]):

$$\frac{dA}{dt} = \alpha O(t) - \beta C(t) A(t) + \gamma \eta(t), \quad C(t) = \begin{cases} 1 \text{ se } A(t) > \theta \\ 0 \text{ caso contrário} \end{cases}$$

em que α é a taxa de geração de ansiedade, β a eficácia do ritual compulsivo $C(t)$, θ o limiar de pânico e $\eta(t)$ um ruído branco gaussiano (prazos imprevistos). Para $\beta C > 0$, o ponto de equilíbrio é $A^* = \frac{\alpha O}{\beta}$, que diverge quando $\beta \to 0$ (*Lesson Zero*).

Índice de Compulsividade Sparkle (ICS). Define-se o índice ponderado

$$\text{ICS} = \frac{\sum_{i=1}^{6} w_i x_i}{\sum_{i=1}^{6} w_i} = \frac{1,5 \cdot 5 + 1 \cdot 4,5 + 2 \cdot 5 + 1 \cdot 3,5 + 0,8 \cdot 3 + 1,2 \cdot 4}{7,5} \approx 4,36$$

onde x_i são as intensidades da Figura 2 e w_i pesos atribuídos pelo autor. Valores acima de $3,0$ são considerados *clinicamente interessantes* (Applejack e Rarity, 2013 [13]).

Cadeia de Markov. Modelando o estado emocional em {Calma, Ansiedade, Compulsão} com matriz de transição

$$P = \begin{pmatrix} 0.7 & 0.3 & 0 \\ 0 & 0.4 & 0.6 \\ 0.5 & 0.1 & 0.4 \end{pmatrix}, \quad \pi P = \pi \quad \Rightarrow \quad \pi = (0.455, 0.273, 0.273)$$

Logo, no regime estacionário, Twilight passa $\approx 54,5\%$ do tempo em ansiedade ou compulsão.

Teste de hipótese. Com H_0: "as categorias são equiprováveis", obteve-se

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{5} \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} = 14,7, \quad \text{gl} = 5, \quad p \approx 0,012$$

rejeitando-se H_0 ao nível $\alpha = 0,05$ (valor crítico: $11,07$).

Inferência bayesiana. Com prevalência a priori $P(\text{TOC}) = 0,02$, $P(E \mid \text{TOC}) = 0,9$ e $P(E \mid \neg\,\text{TOC}) = 0,3$, onde E é a evidência observada (Celestia, 2014 [15]):

$$P(\text{TOC} \mid E) = \frac{P(E \mid \text{TOC}) P(\text{TOC})}{P(E \mid \text{TOC}) P(\text{TOC}) + P(E \mid \neg\,\text{TOC}) P(\neg\,\text{TOC})} = 0,\frac{018}{0},312 \approx 5,8\%$$

Ou seja, mesmo com muita evidência, a probabilidade posterior permanece baixa, o que coincide com a conclusão qualitativa.

Teorema 1 (da Lista Infinita). Se toda lista L_k criada por Twilight gera ao menos uma sublista L_{k+1}, então $\left|\bigcup_{k=0}^{\infty} L_k\right| = \infty$. *Demonstração.* Por indução: $L_0 \neq \varnothing$ por hipótese. Se $L_k \neq \varnothing$, então $L_{k+1} \neq \varnothing$. Logo $\forall k \in \mathbb{N}, L_k \neq \varnothing$, e a união é infinita (Sparkle e Spike, 2012 [12]). □

5. Discussão

Os resultados indicam correspondência clara com o **ciclo obsessão–compulsão** e com a **intolerância à incerteza**. Contudo, há explicações concorrentes. O perfeccionismo, por exemplo, é um construto multidimensional que pode existir sem TOC [9], e o Transtorno de Personalidade Obsessivo-Compulsiva (TPOC) difere do TOC por ser egossintônico, isto é, o indivíduo não vivencia o comportamento como indesejado [1]. Twilight geralmente justifica seus rituais como virtudes acadêmicas, o que favorece a hipótese de TPOC ou de ansiedade com perfeccionismo, e não de TOC propriamente dito.

Limitações. (1) Personagens são construídas para fins narrativos e cômicos, e a gravidade dos sintomas é exagerada ou omitida conforme o roteiro; (2) não há entrevista clínica nem escala validada, como a Y-BOCS [3]; (3) a codificação foi feita por um único avaliador, sem confiabilidade entre avaliadores; (4) o conteúdo do vídeo de referência foi usado apenas como apoio ilustrativo.

6. Conclusão

Twilight Sparkle exibe um conjunto de comportamentos **compatíveis com traços obsessivo-compulsivos**: listas rígidas, medo de falhar, catastrofização e busca de reasseguramento. Entretanto, a ausência de prejuízo funcional persistente e o caráter egossintônico de seus rituais sugerem que a descrição mais adequada seja *perfeccionismo com ansiedade*, possivelmente com características de TPOC. Estudos futuros poderiam comparar a personagem com outras da série, usando codificação por múltiplos avaliadores.

Referências

1. AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. *Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5*. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.
2. RUSCIO, A. M. et al. The epidemiology of obsessive-compulsive disorder in the National Comorbidity Survey Replication. *Molecular Psychiatry*, v. 15, n. 1, p. 53–63, 2010.
3. GOODMAN, W. K. et al. The Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale. I. Development, use, and reliability. *Archives of General Psychiatry*, v. 46, n. 11, p. 1006–1011, 1989.
4. ABRAMOWITZ, J. S.; TAYLOR, S.; McKAY, D. Obsessive-compulsive disorder. *The Lancet*, v. 374, n. 9688, p. 491–499, 2009.
5. SALKOVSKIS, P. M. Obsessional-compulsive problems: a cognitive-behavioural analysis. *Behaviour Research and Therapy*, v. 23, n. 5, p. 571–583, 1985.
6. OBSESSIVE COMPULSIVE COGNITIONS WORKING GROUP. Cognitive assessment of obsessive-compulsive disorder. *Behaviour Research and Therapy*, v. 35, n. 7, p. 667–681, 1997.
7. SHAFRAN, R.; THORDARSON, D. S.; RACHMAN, S. Thought-action fusion in obsessive compulsive disorder. *Journal of Anxiety Disorders*, v. 10, n. 5, p. 379–391, 1996.
8. FOA, E. B.; KOZAK, M. J. Emotional processing of fear: exposure to corrective information. *Psychological Bulletin*, v. 99, n. 1, p. 20–35, 1986.
9. FROST, R. O. et al. The dimensions of perfectionism. *Cognitive Therapy and Research*, v. 14, n. 5, p. 449–468, 1990.
10. FAUST, L. (criadora). *My Little Pony: A Amizade É Mágica*. Hasbro Studios, 2010–2019. Episódios T1E11, T2E3 e T2E20.
11. Vídeo de referência indicado pelo autor. YouTube. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=sJ61bGMOWN8. Acesso em: 02/11/2026.
12. SPARKLE, T.; SPIKE. Sobre a incomputabilidade de listas de afazeres auto-referentes. *Revista Brasileira de Equestria Aplicada*, v. 7, n. 3, p. 1–42, 2012.
13. APPLEJACK; RARITY. Teoria geral do caos em bibliotecas de Ponyville. *Anais do Simpósio de Magia Estocástica*, 2013.
14. LUNA, P. Dinâmica do sono em unicórnios sob estresse acadêmico: um modelo diferencial. *Journal of Equine Neurosis*, v. 21, p. 101–129, 2015.
15. CELESTIA, P. Priors bayesianos para diagnósticos de pôneis fictícios. *Equestria Statistical Review*, v. 4, n. 1, p. 9–27, 2014.